

NEUTROPENIA FEBRIL — ATB EM <1H SEMPRE

DEFINIÇÃO E CAUSAS NÃO-ONCOLÓGICAS

Aspecto	Detalhe
Definição	Neutrófilos < 500/mm ³ (ou < 1000 com previsão de queda) + febre ($\geq 38,3$ C única ou ≥ 38 C por 1h)
Medicamentosa	Metimazol/propiltiouracila, dipirona, sulfas, clozapina, anticonvulsivantes, antibióticos
Infecciosa	Vírus (HIV, dengue, EBV, CMV), sepse com consumo
Imune/medular	Anemia aplásica, neutropenia autoimune, síndrome mielodisplásica
Nutricional	Deficiência de B12/folato
Outras	Hiperesplenismo, neutropenia étnica benigna (não cursa com infecção grave)

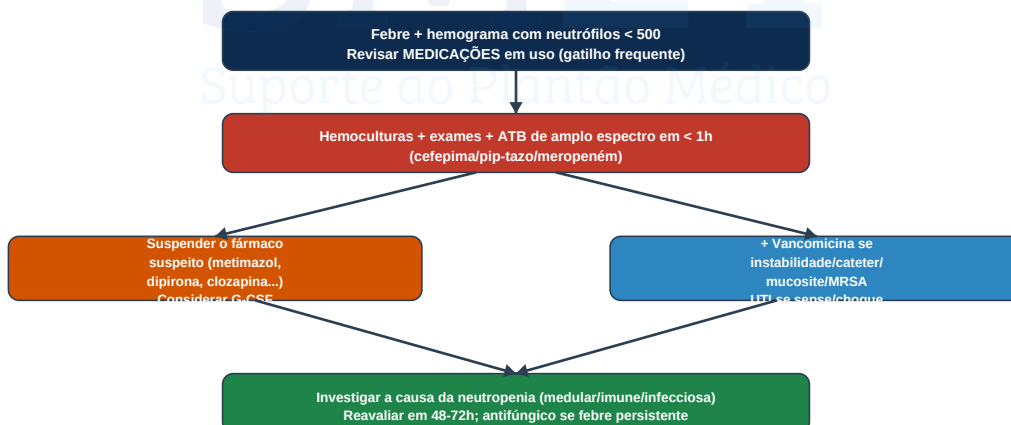
A REGRA É A MESMA DO PACIENTE ONCOLÓGICO

FEBRE + NEUTROPENIA = ANTIBIÓTICO DE AMPLO ESPECTRO EM ATÉ 1 HORA

- Independe da causa: febre + neutropenia exige antibiótico de amplo espectro com cobertura antipseudomonas em < 1 hora
- Coletar hemoculturas (2 sítios, incluindo cateter se houver) ANTES do antibiótico, mas sem atrasar o ATB
- ATB empírico: cefepima OU piperacilina-tazobactam OU meropeném
- Adicionar vancomicina se: instabilidade, infecção de cateter, mucosite grave, pele/partes moles ou suspeita de MRSA
- SUSPENDER imediatamente o fármaco suspeito de causar a neutropenia (ex.: metimazol, dipirona, clozapina)
- G-CSF (filgrastim) pode acelerar a recuperação na neutropenia medicamentosa/grave
- Estratificar gravidade (sepse) e definir o nível de cuidado (UTI se choque)

ABORDAGEM

FEBRE + NEUTROPENIA -> ATB JÁ + ACHAR A CAUSA



FÁRMACOS CLASSICAMENTE ASSOCIADOS

Classe	Exemplos	Observação
Antitireoidianos	Metimazol, propiltiouracila	Agranulocitose; orientar o paciente a procurar o PS se febre
Analgésico/antitérmico	Dipirona (metamizol)	Agranulocitose idiossincrática
Antipsicótico	Clozapina	Exige monitorização hematológica programada
Antibióticos	Sulfas, betalactâmicos, vancomicina	Neutropenia por uso prolongado
Anticonvulsivantes	Carbamazepina, fenitoína	Discrasias sanguíneas
Outros	Quimioterápicos não oncológicos (imunossupressores), tionamidas	Sempre revisar a lista de medicamentos

CUIDADOS E INVESTIGAÇÃO

Medidas Imediatas

- Antibiótico de amplo espectro em < 1 hora (cobrir Pseudomonas)
- Hemoculturas antes do ATB (sem atrasar)
- Suspende o fármaco potencialmente causador
- Precaução de contato/isolamento protetor conforme o serviço
- G-CSF na agranulocitose medicamentosa/grave (acelera recuperação)
- Reavaliar e descalonar conforme cultura

Investigar a Causa

- Revisar minuciosamente todos os medicamentos e o tempo de uso
- Hemograma com avaliação das outras séries (pancitopenia?)
- Sorologias virais (HIV, hepatites, EBV/CMV)
- B12 e folato
- Esfregaço de sangue periférico; mielograma se citopenia persistente/inexplicada
- Encaminhar à hematologia se neutropenia mantida

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Febre + neutrófilos < 500 = emergência, qualquer que seja a causa
- ☐ Hemoculturas + antibiótico de amplo espectro (antipseudomonas) em < 1 hora
- ☐ Adicionar vancomicina se instabilidade, cateter, mucosite ou suspeita de MRSA
- ☐ Suspende imediatamente o fármaco suspeito (metimazol, dipirona, clozapina, etc.)
- ☐ Considerar G-CSF na agranulocitose medicamentosa/grave
- ☐ Investigar a causa (medular, imune, infecciosa, nutricional) e encaminhar à hematologia

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente em uso de metimazol há 3 semanas chega com febre e odinofagia. Hemograma: neutrófilos 300/mm³. Qual a conduta?

- A) Antitérmico e alta
- B) Suspender o metimazol + hemoculturas + antibiótico de amplo espectro (antipseudomonas) em menos de 1 hora
- C) Aguardar a cultura para iniciar o antibiótico
- D) Apenas antibiótico oral domiciliar
- E) Manter o metimazol e observar

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Sobre a neutropenia febril não-oncológica, qual afirmação é correta?

- A) Pode-se aguardar 24h para iniciar o antibiótico
- B) A conduta de antibiótico precoce de amplo espectro é a mesma do paciente oncológico
- C) Nunca usar antibiótico se a causa for medicamentosa
- D) Não há necessidade de hemoculturas
- E) Só tratar se houver foco evidente

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual antibiótico empírico é adequado por cobrir *Pseudomonas* na neutropenia febril?

- A) Amoxicilina oral
- B) Cefepima (ou piperacilina-tazobactam, ou meropeném)
- C) Azitromicina
- D) Ceftriaxona isolada
- E) Nitrofurantoína

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Além do antibiótico, qual medida é essencial quando a neutropenia é atribuída a um medicamento?

- A) Aumentar a dose do medicamento
- B) Suspender imediatamente o fármaco suspeito
- C) Trocar por outro da mesma classe
- D) Manter e observar
- E) Reduzir pela metade a dose

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual fármaco usado no hipertireoidismo pode causar agranulocitose, exigindo orientação para procurar o PS em caso de febre/odinofagia?

- A) Levotiroxina
- B) Metimazol (ou propiltiouracila)
- C) Propranolol
- D) Iodo
- E) Prednisona

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Febre + odinofagia + neutrófilos 300 em uso de metimazol = agranulocitose medicamentosa com neutropenia febril. Conduta: suspender o metimazol, coletar hemoculturas e iniciar antibiótico de amplo espectro (antipseudomonas) em < 1 hora — mesma regra do paciente oncológico.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A neutropenia febril, independentemente da causa (oncológica ou não), exige antibiótico de amplo espectro precoce (< 1 hora). A abordagem é a mesma; adicionalmente, suspende-se o fármaco causador quando identificado.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O antibiótico empírico deve cobrir *Pseudomonas*: cefepima, piperacilina-tazobactam ou meropeném. Adiciona-se vancomicina em situações específicas (instabilidade, cateter, mucosite, MRSA).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Quando a neutropenia é atribuída a um medicamento, é essencial suspender imediatamente o fármaco suspeito (ex.: metimazol, dipirona, clozapina), além do tratamento antibiótico. Considerar G-CSF para acelerar a recuperação.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O metimazol (e a propiltiouracila) pode causar agranulocitose. O paciente deve ser orientado a suspender a medicação e procurar o PS imediatamente em caso de febre ou odinofagia, para avaliação do hemograma.

SM24
Suporte ao Plantão Médico